

УДК: 616.22-006

Д.Х. Савхатов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Вопросы своевременной диагностики злокачественных новообразований полости носа и придаточных пазух в поликлинических условиях

Аннотация.

Своевременная диагностика злокачественных опухолей полости носа и придаточных пазух включает рентгенологические исследования, компьютерную томографию

Цель исследования – проведение «своевременной» диагностики злокачественных новообразований ПН и ПП с учетом объективных и субъективных данных.

Необходимо провести методологические подходы к получению материала для морфологического исследования в области, где патологический очаг наиболее близко прилежит к интактной слизистой оболочке или находится глубже, позволяют в 96,8% случаев достичь подтверждения характера процесса.

Таким образом, своевременная диагностика злокачественных опухолей полости носа и придаточных пазух позволит своевременно поставить диагноз.

Ключевые слова: опухоли полости носа, рентгенологические исследования.

Актуальность

Злокачественные опухоли полости носа (ПН) и придаточных пазух (ПП), располагаясь в костях лицевого черепа, проявляются весьма разнообразной симптоматикой и в процессе своего роста приводят к глубоким психологическим и физическим страданиям для пациента.

Анализ историй болезни 125 больных злокачественными опухолями полости носа и придаточных пазух, большинство больных поступают на лечение при T_3 - T_4 стадиях распространения первичного очага (80,4%), а у 70% из них уже определяются регионарные метастазы. Естественно, что лечение этих больных не всегда приводит к успеху и результат снижается по мере распространения процесса, несмотря на проводимое лечение.

В связи с довольно большим разнообразием первичных жалоб круг врачей, к которым обращаются больные, довольно широк: оториноларингологи, стоматологи, окулисты, невропатологи, хирурги и терапевты. К тому же такие больные в 70% случаев обращаются в первые 3 месяца от момента появления первых беспокоящих их симптомов, остальные - в более поздние сроки. Только у половины из обратившихся в первые 3 месяца больных диагноз устанавливался в сроки до 3 месяцев, а у 28% - даже более 6 месяцев.

Специальное лечение начиналось только у 1/3 больных в первые 3 месяца от момента обращения

к врачу, а лечение, не соответствующее характеру заболевания или наблюдения, проводилось в сроки от 3 до 12 месяцев.

Приведенные выше данные указывают, что судьба онкологического больного в значительной степени зависит от врача-специалиста, работающего в поликлинике, к которому они обращаются.

С практической точки зрения представляется важным предложение Л.И. Гнатышак (1975) различать в клинической стадии развития рака два понятия: «ранняя» и «своевременная» диагностика. «Ранняя» - распознавание опухоли в стадии интраэпителиального роста. «Своевременная» - распознавание опухоли в такой фазе, когда она может быть излечена у подавляющего большинства больных (T_1T_2).

«Своевременная» диагностика в основном зависит от профессиональной компетентности врача поликлиники, куда на I этапе обращаются больные с онкопатологией.

Ошибки на любой стадии обследования больного можно разделить на субъективные и объективные. К субъективным ошибкам относятся: недостаток профессиональных знаний, неполноценность обследования, легкость и неосторожность суждений.

Объективные ошибки могут быть обусловлены: бессимптомным течением заболевания, расположением опухоли в малодоступной для обследования области, маскировкой опухоли наслонившимся воспалительным процессом.

Цель исследования – проведение «своевременной» диагностики злокачественных новообразований ПН и ПП с учетом объективных и субъективных данных.

Злокачественные новообразования полости носа и придаточных пазух составляют 15-20% поражений верхних дыхательных путей, встречаются одинаково часто как у мужчин, так и у женщин. С возрастом частота их нарастает: соединительнотканые опухоли чаще наблюдаются у детей и лиц молодого возраста, а эпителиальные - у лиц старше 40 лет.

В настоящее время в онкологическое учреждение госпитализируется лишь около 20% больных в Г—II, а остальные 80% - в III-IV стадии.

К каким специалистам обращаются больные? В таблице 1 указаны специалисты и наиболее частые их жалобы больных.

Таблица 1 - Специалисты и жалобы больных

Специалист	Жалобы больного
Оториноларинголог	Нарушение носового дыхания, нарушение обоняния, патологические выделения из носа, асимметрия лица, головная боль

Стоматолог	Боль в зубах, расшатывание зубов, деформация альвеолярного отростка, опухоль в области альвеолярного отростка или твердого неба, затруднение открывания рта (тризм)
Окулист	Слезотечение, ухудшение зрения, смещение глазного яблока
Хирург	Увеличение шейных лимфатических узлов
Невропатолог	Невралгические боли в области лица и челюсти, головные боли

(М - 3,9±1,25), чем и объясняется столь высокий удельный вес запущенности.

Раньше всего обращаются за лечебной помощью больные с новообразованиями лобной и основной пазух (2,94±0,9 мес), при этом они направляются в онкоучреждение через 6,3±2,0 мес от момента появления первых беспокоящих их симптомов. Соответствующие цифры при новообразованиях полости носа и решетчатого лабиринта составили 3,75±1,2 и 2,85±0,9 мес, а челюстной пазухи - 5,1 ±1,6 и 4,2±1,35 мес.

В общей сложности больные злокачественными опухолями ПН и ПП обращаются к врачам за лечебной помощью в среднем через 4,92±1,6 мес

от момента появления первых симптомов заболевания, а попадают в онкологическое учреждение через 8,8±2,9 мес.

В методику ЛОР осмотра входит:

- Оценка симметричности анатомических элементов лица, глазных щелей, наличия птоза, экзофтальма, подвижности глазных яблок, окраски и тургора кожи лица.

- Оценка полноценности носового дыхания: дыхание затруднено, отсутствует с одной или обеих сторон.

- Оценка характера отделяемого из носа: слизистое, слизисто-гнойное, гнойное, сукровичное, кровотечение.

- Передняя риноскопия: наличие опухоли, инфильтрата, его локализация.

- При необходимости - анемизация носовых ходов, средняя риноскопия или зондирование пуговчатым зондом.

- Если передняя риноскопия не дает информации о причинах затруднения или отсутствия носового дыхания - задняя риноскопия, после анемизации глотки.

- Ороскопия и выявление расшатывания зубов, наличия опухоли или инфильтрата в области твердого неба или переходной складки десны верхней челюсти.

- Пальпация наружного носа, верхнего и нижнего края орбиты, лицевой стенки лобной и челюстной пазух, твердого неба и переходной складки десны в области верхней челюсти позволяет выявить инфильтративный рост при целостности кожи и слизистой оболочки.

- Исследование чувствительности кожи лица и губ, слизистой оболочки губ и преддверия полости рта выявляет вовлечение в процесс крыло-небного узла.

- Исследование полноты раскрытия рта (выявление тризма) - признак вовлечения в опухолевый процесс крыло-челюстных мышц.

Фиброэндоскопия в диагностике злокачественных новообразований полости носа и придаточных пазух ограничена в связи с тем, что полость носа имеет сложную конфигурацию и наконечник эндоскопа не может проникнуть в носовые ходы и купол носа, а тем более в придаточные пазухи. Эндоскопически можно осмотреть общий носовой ход и задние отделы полости носа. Фиброэндоскопия полости носа рекомендуется при подозрении на опухоль и невозможности уточнить диагноз обычной риноскопией.

Лучевая диагностика злокачественных новообразований полости носа и придаточных пазух включает проведение рентгенологического исследования,

Таблица 2 - Устанавливаемые диагнозы и проводимое лечение

Специалист	Диагноз	Лечение
Оториноларинголог	Гайморит, этмоидит, фронтит, гипертрофический ринит, полипоз носа, искривление носовой перегородки	Капли в нос, перемещение лекарственных веществ по Процыку, пункции гайморовых пазух, удаление полипов, гайморотомия, физиотерапевтические процедуры
Стоматолог	Пульпит, кариес, пародонтоз, периодонтит, периостит, кисты прикорневые, одонтогенная невралгия, невралгия крыло-небного узла	Полоскание, пульпэктомия, удаление кариозных (а порой интактных) зубов, разрезы слизистой оболочки, физиотерапевтические процедуры
Окулист	Закупорка слезно-носового канала, дакриоцистит, катаракта, патология глазного дна, воспаление параорбитальной клетчатки, киста	Зондирование и промывание слезного канала, разрезы параорбитальной области, глазные капли
Хирурги	Банальный лимфаденит, туберкулезный лимфаденит	Противовоспалительное, противотуберкулезное и физиотерапевтическое, хирургическое удаление
Невропатолог	Невралгия I-II ветви тройничного нерва, арахноидит	Иглоукалывание, витаминотерапия, рассасывающая терапия, физиопроцедуры

Наиболее часто устанавливаемые диагнозы и проводимое лечение указаны в таблице 2.

Такой широкий спектр обращений к разным специалистам обусловлен тем, что полость носа и придаточные пазухи граничат с глазницей, полостью черепа, а челюстная пазуха, кроме того, с полостью рта.

Симптоматика характерна для опухолей полости носа и придаточных пазух описана в таблице 3.

При поражениях полости носа и решетчатого лабиринта высок уровень носовых, глазных и неврологических симптомов. При поражениях лобной и основной пазух симптоматика крайне скудна и складывается из неврологических и глазных симптомов. При поражениях челюстных пазух спектр симптомов настолько разнообразен, что отдать предпочтение одному из них как патогномоничному для злокачественной опухоли практически невозможно.

Визуально опухоль определялась у 44,0% больных в полости носа, у 9,6% - в области альвеолярного отростка и твердого неба, у 7,2% - «врастание» в кожу лица, т.е. процессы были запущенными.

Сроки обращения к врачам больных злокачественными опухолями полости носа и придаточных пазух

Даже в не ранние сроки обращения больных от момента появления беспокоящих симптомов (4,92±1,6 мес) проходит довольно длительное время для установления диагноза и направления в онкологическое учреждение

к которому относятся: флюорография (крупнокадровая), рентгенография (в прямой проекции), иногда с контрастированием, томография, проводимая в зависимости от результатов рентгенографии.

Результаты этих исследований носят достаточно условный характер и зависят как от технических погрешностей при укладке больного и неправильной центрации лучей, так и от особенностей структуры костей лицевого черепа. Приблизительно в 50% случаев не выявляются изменения воздушности лобных и в 12% - челюстных пазух.

Известные рентгенологи М.Х. Файзуллин (1961), К.Л. Лихтенштейн (1962) отмечают, что даже детальное лучевое исследование не только не позволяет распознать, но даже заподозрить злокачественное новообразование, и даже томография в ранних фазах ничего не вносит нового в клинические данные.

Тем не менее, указанные авторы рекомендуют руководствоваться следующей рентгенологической симптоматикой (таблица 4).

Однако в клинической практике патогномичность этих симптомов только для злокачественных новообразований оказалась весьма сомнительной, поскольку такие же симптомы, вплоть до деструкции костей, мы выявили и при доброкачественных опухолях, и при опухолевидных процессах, и при гранулематозных поражениях, и даже хронических гнойно-полипозных синуситах. Но при сопоставлении с клиническими данными рентгенологическое выявление перечисленных симптомов может служить достаточно серьезным аргументом в пользу дальнейшего уточнения характера процесса.

В этом плане большими возможностями обладает компьютерная томография (КТ). КТ позволяет увеличивать изображение в целом и отдельных зон, складывать поперечные срезы и получать продольное изображение или делать разовый томографический снимок, что предоставляет возможность дифференцировать отдельные органы и мягкие ткани, получать срезы в 4 мм для выявления тонких структурных изображений и выявлять опухоли диаметром 0,5 см.

Применение КТ у 34 больных злокачественными новообразованиями ПН и ПП позволило в 22 случаях (64,7%) получить дополнительную топографоанатомическую информацию о состоянии основной пазухи, каждой из клеток решетчатого лабиринта; медиальной, наружной, лицевой стенок челюстной и лобной пазух; размерах опухоли, орбитальной распространенности, заинтересованности крыло-челюстной ямки.

С точки зрения разрешающих возможностей, безусловно, КТ не идет ни в какое сравнение с другими методами лучевой диагностики при исследовании придаточных пазух носа.

Методологические подходы к получению материала для морфологического исследования. Разнообразие патологических процессов ПН и ПП (более 65 наименований согласно международной гистологической классификации), клиническая и рентгенологическая симптоматика которых, вплоть до

Таблица 3 - Клиническая симптоматика злокачественных опухолей полости носа и придаточных пазух

Симптомы	Полость носа и решетчатый лабиринт		Лобная и основная пазухи		Челюстная пазуха		Всего	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Затруднение носового дыхания	38	100,0	-	-	41	52,56	79	63,2
Нарушение обоняния	23	60,53	2	22,2	18	23,08	43	34,4
Гнойные выделения	13	34,21	-	-	15	19,23	28	22,4
Сукровичные выделения	17	44,74	-	-	37	43,43	54	43,2
Кровотечения	9	23,68	-	-	12	15,38	21	16,8
Видимая опухоль в полости носа	31	81,68	-	-	24	30,77	55	44,0
Слезотечение	12	31,58	-	-	15	19,23	27	21,6
Смещение глаза	7	18,42	4	44,4	8	10,26	19	15,2
Ухудшение зрения	-	-	2	22,2	8	10,26	19	15,2
Боль в зубах (при интактности)	-	-	-	-	19	24,36	19	15,2
Расшатывание зубов	-	-	-	-	11	14,10	11	8,8
Деформация альвеол, отростка	-	-	-	-	24	30,77	24	19,2
Видимая опухоль альвеол, отростка	-	-	-	-	18	23,08	18	14,4
Тризм	-	-	-	-	12	15,38	12	9,6
Видимая опухоль лица	2	5,26	2	22,2	46	58,27	50	40,0
Врастание в кожу	1	2,63	-	-	8	10,26	9	7,2
Невралгия	21	53,26	9	100,0	66	77,42	96	76,8
	38	30,4	9	7,2	78	62,4	125	100,0

Таблица 4 – Рентгенологическая симптоматика

Причины симптомов	Симптомы
1. Заполнение пазухи опухолью	Тотальное затемнение, частичное затемнение
2. Распространение процесса за пределы пазухи	А. В мягкие ткани: - регионарное затемнение - деформация глазничной тени - тень опухоли Б. В кости: - дефекты в тенях костей В. В окружающие ткани: - затемнение просвета полости носа - затемнение просвета остальных придаточных пазух

деструктивных изменений в костях, перекрывают друг друга, диктует необходимость уточнения морфологической сущности процесса для определения рациональной тактики лечения. Однако скрытое расположение патологии в костных полостях лицевого черепа не всегда позволяет получить достаточный материал из очага заболевания для гистологического изучения. По данным литературы, удельный вес таких случаев составляет от 30 до 40%. По нашим наблюдениям, такие больные составили 38,4% (даже при условии значительной распространенности из полости носа - 15,8%, лобной и основной пазух - 100%, челюстной пазухи - 42,31%).

В связи с указанным, мы рекомендуем следующие методологические подходы к получению материала для морфологической верификации характера процесса.

1. При визуальной доступности опухоли (врастание в полость носа, переходную складку десны, альвеолярный отросток, твердое небо, кожу лица) - биопсия.

2. При визуальной доступности:

а) исследовать промывную жидкость из гайморовой пазухи (использовать только теплый физиологический раствор);

б) исследовать пунктаты: из клеток решетчатого лабиринта, из лобных пазух, из переходной складки десны, из инфильтрата в области fossa canina, из инфильтрата в области скуловой кости, из шейного лимфатического узла (если он определяется).

Такие методологические подходы к получению материала для морфологического исследования в области, где патологический очаг наиболее близко прилежит к интактной слизистой оболочке или находится глубже, позволяют в 96,8% случаев достичь подтверждения характера процесса.

Таким образом, своевременная диагностика злокачественных опухолей полости носа и придаточных пазух довольно сложна и должна складываться из следующих этапов:

1. Тщательный анамнез «органных» жалоб и анамнеза заболевания.

2. Квалифицированный ЛОР осмотр.

Эти два момента служат отправной точкой для предварительного диагноза.

3. Рентгенологическое исследование (в носоподбородочной или носо-лобной проекции). При необходимости - томография.

4. Компьютерная томография придаточных пазух носа рекомендуется в тех случаях, когда клинические и рентгенологические данные не дают достаточной информации о характере процесса и его распространенности в окружающие тканевые структуры.

5. Если клиничко-рентгенологические исследования

дают основание для подозрения на злокачественность процесса, то необходимо переходить к этапу морфологической (гистологической, цитологической) верификации одним из рекомендуемых нами доступов.

Тұжырым

Д.Х. Савхатов

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институті

Поликлиникалық жағдайда мұрын қуысы мен қосалқы қойнауларындағы қатерлі жаңа түзілімдерді заманауи диагностикалау туралы сұрақтар

Жоғарғы тыныс жолдарының зақымдануының 15-20% мұрын қуысы мен қосалқы қойнауларындағы қатерлі жаңа түзілімдер құрайды. 125 науқас ауруына анализ жүргізу.

Түйінді сөздер: мұрын қуысы мен қосалқы қойнауларындағы қатерлі жаңа түзілімдер, диагностика.

SUMMARY

D.H.Savhatov

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Questionstimesly diagnosis oral cancer

The nose and paranasal sinuses in the polyclinic Conditions.

Malignant tumors of the nasal cavity and paranasal sinuses constitute 15-20% of lesions of the upper respiratory tract. An analysis of 125 patients with diseases. Developed some of the methodological approaches to the preparation of material for morphological verification of the nature of the process.

Keywords: Malignant tumors of the nasal cavity and paranasal sinuses